

(X) ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 22232865097 | 234

ANA BEATRIZ BARROS OLIVEIRA

IDADE: 24 PESO: 90 ALTURA: 170 PROFISSÃO: estudante
SINTOMAS: sonolência / cansaço
QUEIXAS: enxaqueca / sensação de mm II.
MEDICAMENTOS: Aleltor / Sintroid / Serehid

MÉDICO: Drº Alberto Remesar

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: não consegue voltar após gripe

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: 5 LANCHE: JANTAR: 5

HORA QUE DORME: 00:00 HORA QUE ACORDA: 9h

COCHILLO () SIM (X) NÃO DORME ACOMPANHADO (X) SIM (X) NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO

FUMO () SIM () NÃO / DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: não BANHEIRO: 2x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: ↑ CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: sim MALLAMPATI: IAH: 8,5 e / m SPO2: 79%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Rinite / Sinusite

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: IMC:

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS banhar / ciático

13/09/24 Avaliação

20/09/24 P=10 cm H₂O
IAH= 1,3 e/h
mdc uso: 10h 10'
fuga: 9,2 l/m

Relata estar mais
disposta e menos
sonolenta
Natasha

04/10/24 P=10 cm H₂O
IAH= 1,8 e/h
mdc uso: 6h 35'
fuga: 9,7 l/m

Bem adaptada
Natasha

19/11/24 P=10 cm H₂O
IAH= 1,0 e/h
mdc uso: 10h 10'
fuga: 10,2 l/m

Bem adaptada
Demora em média 2h
p/ dormir
faz tratamento p/ ansiedade

18/03/25 P=10 cm H₂O
IAH= 1,6 e/h
mdc uso: 10h 40 min
fuga: 12 l/min

Natasha
Bem adaptada
Silvia

28/05/25 P=10 em H₂O

IAH= 0,9 e/h

m de ura: 10h30'

fuop: 7,9 e/h m

Bem adaptada

3/ queixas

Natasha



Clínica
DR. ALBERTO REMESAR
Psiquiatria do bem-estar

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Psiquiatria pela UFRJ
Mestre em Psiquiatria pela UFRJ
Doutor em Ciências pela UNIFESP
Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono
CRM 69.730 - RQE 40.178

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Ana Beatriz Barros Oliveira
EXAME nº: 5667-2 CPAP
SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
DATA: 09/09/2024
IDADE: 24 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h36min e concluído às 05h59min. A latência para o sono foi de 23 minutos. O tempo total de sono foi de 313,5 minutos (05h13min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 71,7%. A distribuição do sono registrado mostrou 42,4% de estágio 1, 34,9% de estágio 2, 22,6% de estágio 3 e 0% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 100,5 minutos em vigília, ocorreram 167 microdespertares (índice: 32/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 26,4/hora, sendo 13,6 apneia/hora e 12,8 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 26,4/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 98%, sendo a média de 95% e a mínima de 87%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

A paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ela usou a máscara nasal Mirage Activa medium (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 10,2 cm de H₂O.

Registraram-se aumentos moderados dos índices de apneia/hipopneia (26,4/hora; índice moderado: 15 a 30/hora) e de distúrbio respiratório (26,4/hora), episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina, despertares e o ritmo cardíaco foi sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 76; máxima: 106 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

A paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 23 min; normal até 30 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 71,7%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 32/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) durante o estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (42,4%; normal: 5%) e 3 (22,6%; normal: 15-20%), e a redução do estágio 2 (34,9%; normal: 45-55%). Sem estágio REM (0%; normal: 20-25%).

Sem movimentos periódicos de membros.

Avenida Dr. João Guilhermino, 474, sl 51 e 52
Ed. Office Tower - Centro - São José dos Campos
Tel: (12) 3913-2162 | (12) 3941-2449 | (12) 99622-8008

*Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez*
Médico
CRM 69730

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Ana Beatriz Barros Oliveira

EXAME nº: 5667

SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez

DATA: 24/07/2024

IDADE: 24 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h42min e concluído às 06h09min. A latência para o sono foi de 14 minutos e a latência para o estágio REM, de 67 minutos. O tempo total de sono foi de 340 minutos (05h40min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 76,6%. A distribuição do sono registrado mostrou 22,6% de estágio 1, 59,4% de estágio 2, 14,6% de estágio 3 e 3,4% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 89,5 minutos em vigília, ocorreram 124 microdespertares (índice: 21,9/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 85,1/hora, sendo 15,4 apneia/hora e 69,7 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 85,1/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, sendo a média de 95% e a mínima de 79%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (85,1/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (85,1/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 74; máxima: 106 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 14 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava encurtada (67 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 76,6%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 21,9/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) durante o estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (22,6%; normal: 5%) e 2 (59,4%; normal: 45-55%), e a redução do estágio REM (3,4%; normal: 20-25%). A porcentagem do estágio 3 (14,6%; normal: 15-20%) permaneceu no limite inferior da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 3 (normal até 9; máxima: 24).